Хронический тонзиллит

Клинические рекомендации от 20.11.2024 · взрослые и дети

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/683_2. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

- **J35.0** Хронический тонзиллит — при воспалении нёбных миндалин
- **J35.8** Другие хронические болезни миндалин и аденоидов — при воспалении язычной, трубных или глоточной миндалины
- **J35.9** Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточнённая
- **J31.1** Хронический назофарингит

Главное

- Диагноз ставят по фарингоскопии: решают местные признаки хронического воспаления миндалин, и важнее всего жидкий гной в лакунах. Размер миндалин для диагноза значения не имеет.
- Во время острого воспаления глотки хронический тонзиллит не диагностируют: признаки можно достоверно оценить только через 3–4 недели после него.
- По классификации Солдатова тонзиллит бывает компенсированным и декомпенсированным; форму определяют по анамнезу за последние три года.
- Консервативное лечение проводят курсами между обострениями: при компенсированной форме 2 раза в год, весной и осенью, при рецидивах ангин — до 4 раз в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемого обострения.
- Тонзиллэктомия показана при любой декомпенсации, а при рецидивирующих ангинах — если противорецидивное лечение не помогло.

Клиника и классификация

Определение

Хронический тонзиллит — инфекционно-аллергическое заболевание всего организма с местными проявлениями: стойким воспалением нёбных миндалин с альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

Местные признаки

Выделяют пять групп местных признаков: гиперемия и валикообразное утолщение краёв нёбных дужек; рубцовые спайки между миндалинами и дужками; разрыхлённые или, наоборот, рубцово изменённые и уплотнённые миндалины; казеозно-гнойные пробки или жидкий гной в лакунах; увеличенные регионарные лимфоузлы.

Признак Гизе — гиперемия краёв передних дужек. Признак Зака — отёк в месте соединения передних и задних дужек. Признак Преображенского — валикообразное утолщение краёв верхних отделов передних и задних дужек.

Классификация Солдатова

При компенсированной форме местные признаки видны, а общих симптомов почти или совсем нет. При декомпенсированной к местным признакам добавляется хотя бы один вид декомпенсации: рецидивы ангин; паратонзиллит или паратонзиллярный абсцесс; тонзиллогенная интоксикация — долгий субфебрилитет, недомогание, снижение трудоспособности без другой причины; тонзиллогенные функциональные нарушения внутренних органов; заболевания органов, связанные с тонзиллитом. Форму определяют по анамнезу за последние три года.

Классификация Преображенского — Пальчуна

При простой форме есть только местные признаки, и почти всегда в анамнезе были ангины.

При токсико-аллергической форме I степени периодически бывают субфебрилитет, слабость, быстрая утомляемость, боли в суставах, увеличенные и болезненные регионарные лимфоузлы, непостоянные функциональные нарушения со стороны сердца и нестойкие отклонения в анализах.

При II степени функциональные нарушения сердца подтверждаются на ЭКГ, бывают сердцебиение и нарушения ритма, боли в сердце и суставах во время ангины и вне её, функциональные нарушения почек, печени, суставов и сосудов, а также связанные с тонзиллитом болезни: паратонзиллярный абсцесс, парафарингит, тонзиллогенный сепсис, ревматизм, артрит, приобретённые пороки сердца, гломерулонефрит.

Описано около 100 болезней, связанных с хроническим тонзиллитом; чаще всего страдают сердце, суставы, почки, эндокринная система и кожа. В трудных случаях тактику выбирают вместе с профильным специалистом.

Жалобы и анамнез

Пациенты могут жаловаться на несильную боль, першение, ощущение инородного тела в горле, периодический сухой кашель и неприятный запах изо рта. Эти жалобы неспецифичны — они бывают и при хроническом фарингите, болезнях гортани, полости рта и зубов, — а у части пациентов их нет вовсе.

При декомпенсированной форме бывают общие жалобы: долгое недомогание, снижение работоспособности, затяжной субфебрилитет. Они тоже неспецифичны, поэтому нужно обследование, чтобы исключить другие причины.

У детей и взрослых, особенно часто и долго болеющих, выясняют местные и общие жалобы и уточняют, как часто были ангины. Ангины в анамнезе многие авторы считают самым надёжным признаком хронического тонзиллита, но сведения о них должны быть подтверждены.

Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу (ангины, долгая утомляемость, субфебрилитет, регионарный лимфаденит, болезни, связанные с тонзиллитом), осмотру, лабораторным данным и фарингоскопии.

Осмотр

Фарингоскопию проводят детям и взрослым, чтобы исключить острый тонзиллит и найти местные признаки хронического.

Пока есть острое воспаление глотки, хронический тонзиллит не диагностируют: его признаки можно достоверно оценить только через 3–4 недели.

Всем проводят осмотр верхних дыхательных путей с хорошим освещением, шпателем и зеркалами, фарингоскопию и эпифарингоскопию.

Решающее значение имеют фарингоскопические признаки, и важнее всего жидкий гной в лакунах, часто с неприятным запахом. Увеличение лимфоузлов может быть вызвано и другими воспалительными процессами головы и шеи. Размер миндалин для диагноза значения не имеет.

Осматривают при ярком направленном свете двумя шпателями, при необходимости зондом. За 20–30 минут до осмотра пациенту не стоит есть, пить горячее, холодное и газированное, курить и разговаривать на холоде, чтобы не было преходящей гиперемии. Вторым шпателем надавливают на дужку, чтобы увидеть содержимое лакун и спайки.

Анализы

Общий анализ крови и мочи, СРБ и ревматоидный фактор назначают, чтобы выявить связанное с тонзиллитом заболевание.

Антистрептолизин-О (АСЛ-О) определяют, чтобы отличить активную стрептококковую инфекцию от носительства.

Высокий АСЛ-О без стрептококка в посевах говорит о возможной внутриклеточной персистенции и считается подтверждением декомпенсации. Но высокий АСЛ-О без симптомов со стороны миндалин сам по себе не повод для лечения.

Возраст	Норма АСЛ-О, МЕ/мл
До 7 лет	до 100
7–14 лет	150–200
С 14 лет	до 250

Отделяемое с нёбных миндалин сеют на бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) или делают экспресс-тест.

Анализы крови и мочи, посевы и цитология содержимого лакун для самого диагноза значения почти не имеют. Они нужны, чтобы уточнить форму, роль микрофлоры, связь с болезнями других органов и эффект лечения.

Лазерная допплеровская флоуметрия, УЗИ и другие дополнительные методы пока не получили распространения, доказательств их эффективности нет.

Лечение

Хронический тонзиллит лечат между обострениями. Ангину лечат по рекомендациям по острому тонзиллофарингиту, а паратонзиллит и абсцесс — по рекомендациям по этим заболеваниям.

Перед любым лечением проверяют зубы, околоносовые пазухи и носоглотку и при необходимости санируют их.

Консервативное лечение

Консервативное лечение показано при компенсированной и простой форме — курсами 2 раза в год, весной и осенью. При декомпенсации в виде рецидивов ангин и при токсико-аллергической форме I степени — до 4 курсов в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемой ангины. При других видах декомпенсации и токсико-аллергической форме II степени — если операция противопоказана.

Лечение помогает, только если лакуны дренируются, а складки и карманы очищаются от экссудата и детрита.

Системные антибиотики назначают при обострении, если выделен стрептококк или появляются признаки осложнений, — это пенициллины. Вне обострения, при функциональных нарушениях внутренних органов, отрицательных посевах на БГСА и стойко высоком АСЛ-О, предпочтение отдают 14-членным макролидам, курсом до 2 недель.

Нужны ли антибиотики между обострениями, специалисты спорят, поэтому решение принимают индивидуально, по объективным данным и динамике симптомов и анализов.

Если подтверждена грибковая природа, назначают противогрибковые препараты внутрь с учётом чувствительности.

Между обострениями курсами назначают растительные препараты с корнем алтея, цветками ромашки, травой тысячелистника, корой дуба, травой хвоща и корнем одуванчика, чтобы реже были ангины.

Местное лечение

Между обострениями промывают лакуны миндалин: курс из 10 процедур ежедневно или через день. Промывать можно не раньше чем через 2–3 недели после острого воспаления.

Промывают стерильным раствором натрия хлорида или растворами антисептиков, соблюдая дозы и возрастные ограничения и помня об аллергии на препараты йода. Смазывание миндалин курсом 10–15 процедур проводят отдельно или сразу после промывания.

Детям дошкольного и младшего школьного возраста миндалины не промывают и не смазывают из-за риска рефлекторного ларингоспазма.

Назначают антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций и таблеток для рассасывания.

Взрослым при обострении назначают НПВП для местного применения.

Топические бактериальные лизаты в таблетках для рассасывания уменьшают число и длительность обострений.

В ремиссии пациента консультирует физиотерапевт; перед физиотерапией проводят курс промываний.

Тонзиллэктомия

Двустороннюю тонзиллэктомию делают между обострениями, чтобы радикально убрать очаг инфекции.

По классификации Солдатова операция показана при любой декомпенсации, кроме рецидивов ангин, если противорецидивное лечение не проводилось. При рецидивах ангин — если консервативное лечение не помогло и ангины продолжаются или появился другой вид декомпенсации.

По классификации Преображенского — Пальчуна — при токсико-аллергической форме II степени, а также при простой форме и форме I степени, если 2–3 тщательных курса консервативного лечения в год не помогли.

Детям операция показана при частых стрептококковых ангинах (не меньше 7 за последний год, не меньше 5 в год за последние 2 года или не меньше 3 в год за последние 3 года), при двух паратонзиллярных абсцессах и больше (иногда и после одного) и по заключению профильных специалистов, если операция нужна для лечения сопутствующей болезни.

Критерии Paradise: тонзиллэктомию рассматривают при 7 эпизодах боли в горле за год, 5 в каждом из двух лет или 3 в каждом из трёх лет. Эпизодом считается боль в горле хотя бы с одним признаком: температура 38,3 °C и выше, экссудат на миндалинах, шейные лимфоузлы больше 2 см и болезненные, БГСА в посеве или положительный экспресс-тест.

Абсолютные противопоказания: болезни крови (гемофилия, лейкозы, геморрагические диатезы), аномальные сосуды глотки (пульсация боковой стенки), тяжёлая сердечная недостаточность II–III степени, выраженная почечная недостаточность, тяжёлый сахарный диабет с кетонурией, тяжёлые болезни печени, тяжёлые нервно-психические болезни, злокачественные опухоли, активный туберкулёз.

Относительные противопоказания: острые инфекции и 3–4 недели после них, острые воспаления и обострения хронических, в том числе ЛОР-органов, эпидемии гриппа, менструация, неактивный туберкулёз, преходящая тромбоцитопения, нетяжёлый сахарный диабет, кариозные зубы.

Самое частое осложнение — кровотечение из ниши миндалины во время операции или в первые 5–7 дней, но оно возможно и на 8–15-е сутки. Поэтому первые 5–7 дней пациент лежит в стационаре, а после выписки ещё 5–7 дней наблюдается в поликлинике на больничном.

После операции

В первые сутки пациент соблюдает постельный режим и молчит; через несколько часов можно сделать несколько глотков воды. Дальше режим щадящий, пища жидкая или протёртая, не горячая и не холодная. Назначают местные и системные обезболивающие и предупреждают обострение сопутствующих болезней.

Для обезболивания и уменьшения воспаления назначают НПВП.

После тонзиллэктомии месяц ограничивают физическую нагрузку, соблюдают режим сна и отдыха.

Наблюдение, профилактика, госпитализация

При компенсированной форме курсы лечения проводят 2 раза в год. Если 3 года не было ангин и других признаков декомпенсации, пациента снимают с диспансерного учёта.

При декомпенсации в виде рецидивов ангин курсы проводят 3–4 раза в год. Если за год лечение не помогло, ангины осложняются или появляется другой вид декомпенсации, пациента направляют на операцию.

После тонзиллэктомии пациент находится на диспансерном наблюдении 6 месяцев.

Для профилактики рецидивов и восстановления нормальной микрофлоры ротоглотки применяют БАД с естественными бактериями ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

Риск хронического тонзиллита повышают несбалансированное питание (особенно недостаток витаминов A, B, E), переутомление, плохая гигиена жилья и рабочего места, загрязнённый воздух, курение, в том числе пассивное, болезни зубов, носа и пазух, частые ОРВИ и их неправильное лечение.

Лечит обычно оториноларинголог амбулаторно.

В хирургическое отделение госпитализируют при неэффективности лечения, подозрении на гнойное осложнение (паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит) или новообразование и когда нужна операция. Тонзиллэктомию проводят в ЛОР-отделении планово и выписывают на 5–7-е сутки, если послеоперационный период протекает без осложнений.

Тонзиллит чаще переходит в декомпенсированную форму при иммунодефиците (врождённом, на иммунодепрессантах и цитостатиках, при ВИЧ). Аутоиммунные осложнения вероятнее при стрептококковом тонзиллите и ревматической лихорадке у пациента или близких родственников.

Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический тонзиллит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	683_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

Неточности в самом тексте КР

- В разделе 1.4 указан код J31.1 «Хронический назофарингит», а в карточке рубрикатора — J31.2 «Хронический фарингит». На сайте приведён код из текста КР.
- Бензидамин в комментарии отнесён к «пенициллинам, чувствительным к бета-лактамазам» (код АТХ J01CE) — это ошибка: бензидамин — нестероидный противовоспалительный препарат для местного применения.